AUDIT Alpha

104 cours existants, une IA responsable de chaque cours

PREPARE_NON_LANCE
Planification seule. Aucun audit croisé à ce stade, aucun ordre envoyé à Claude. Les gardes et la coordination proposées doivent être adaptées et vérifiées avant toute correction canonique ou production.

Total	Codex 52	Claude 52

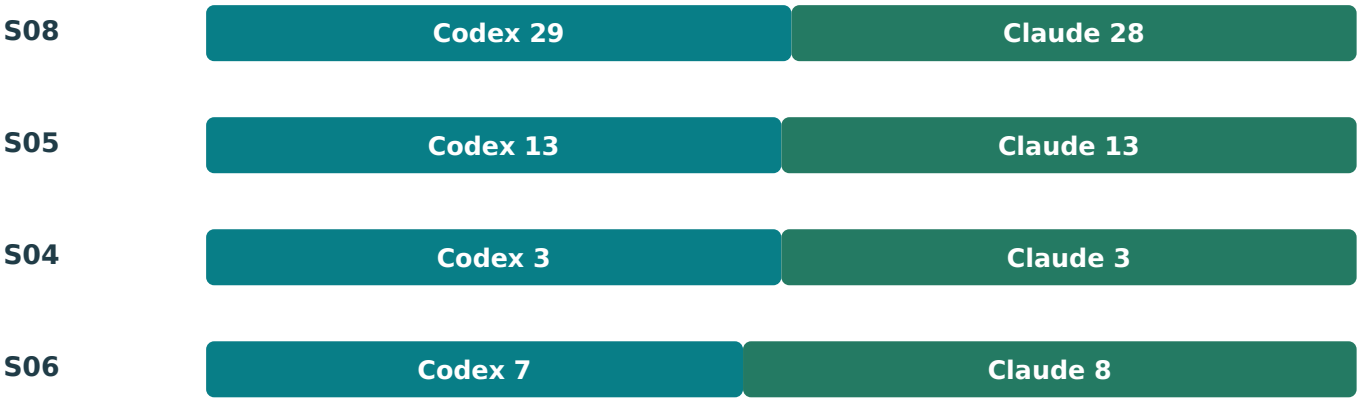
Ce plan attribue exhaustivement les 104 cours publiés de Neurologie, Endocrinologie et métabolisme, Néphrologie et Hématologie. Au lancement : photographier, lire et vérifier, corriger dans un espace attribué puis relire le résultat. L’intégration demeure séquentielle, avec preuves finales et statut honnête.

Un cours entier, une attribution claire

Les sous-codes restent dans la leçon mère. Une branche, un worktree et des chemins propres par tâche ; fichiers partagés remis à un seul intégrateur, rôle temporaire ouvert également aux deux IA. Le cache économise les relectures sans remplacer les preuves.

Base documentaire : 7adf385a5182a8dcf25584dbb53207c620440ad3. Les listes et empreintes complètes figurent dans plan.json ; ces documents décrivent des attributions proposées, jamais une validation médicale humaine.

La parité, système par système



Fragment	N	Codex	Claude	Charge indicative C / Cl
N-05-Neurologie	57	29	28	4003 / 4007
E-06-Endocrinologie et métabolisme	26	13	13	2105 / 2106
N-07-Néphrologie	6	3	3	639 / 727
H-08-Hématologie	15	7	8	1343 / 1268

Chaque leçon complète appartient à une seule IA. Les effectifs impairs entraînent un écart d’un cours, compensé entre systèmes lorsque possible. Les attributions équilibrent aussi les chapitres CIM ; aucune moitié de cours n’est utilisée pour fabriquer le quota.

La charge audit est le volume des sources HTML en Kio, arrondi : un proxy de lecture, jamais une mesure validée de difficulté médicale. La provenance de l’auteur est conservée ; auditer une production de la même IA reste permis à ce stade sans croisement.

Les chapitres, sans déséquilibre caché

C / Cl = Codex / Claude. Un chapitre CIM peut contribuer à plusieurs fragments ; chaque ligne garde le fragment de rattachement. Le périmètre reste les quatre systèmes attribués.

Fragment / chapitre	Intitulé	N	C / Cl
S08 / II	Tumeurs	2	1 / 1
S08 / IX	Maladies de l’appareil circulatoire	8	4 / 4
S08 / VI	Maladies du système nerveux	43	22 / 21
S08 / XVIII	Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	4	2 / 2
S05 / IV	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	26	13 / 13
S04 / XIV	Maladies de l’appareil génito-urinaire	6	3 / 3
S06 / II	Tumeurs	7	3 / 4
S06 / III	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	8	4 / 4

Les lots de conversation

Un lot logistique regroupe normalement 3–4 cours entiers. Un reliquat de 1–2 ou une monographie lourde reste possible. Une conversation de lot conserve une tâche et un dossier distincts par cours ; chaque livraison avance séparément, sans attendre la fin du lot.

Lot	IA	Cours attribués
AA-S08-CODEX-01	Codex	G01, G02, G05, I63
AA-S08-CODEX-02	Codex	I64, C70, G03, G06
AA-S08-CODEX-03	Codex	G07, G08, G09, G21
AA-S08-CODEX-04	Codex	G22, G24, G25, G26
AA-S08-CODEX-05	Codex	G32, G36, G37, G52
AA-S08-CODEX-06	Codex	G53, G55, G57, G59
AA-S08-CODEX-07	Codex	G60, I66, I68, R25
AA-S08-CODEX-08	Codex	R47
AA-S08-CLAUDE-01	Claude	I61, I62, G45, C72
AA-S08-CLAUDE-02	Claude	G23, G58, G63, G64
AA-S08-CLAUDE-03	Claude	G71, G72, G73, G80
AA-S08-CLAUDE-04	Claude	G81, G82, G83, G90
AA-S08-CLAUDE-05	Claude	G91, G92, G93, G94
AA-S08-CLAUDE-06	Claude	G96, G97, G98, G99
AA-S08-CLAUDE-07	Claude	I65, I67, R26, R27
AA-S05-CODEX-01	Codex	E10, E05, E00, E01
AA-S05-CODEX-02	Codex	E02, E07, E14, E25
AA-S05-CODEX-03	Codex	E30, E32, E35, E40
AA-S05-CODEX-04	Codex	E42
AA-S05-CLAUDE-01	Claude	E11, E12, E34, E41

Les lots de conversation — suite

Lot	IA	Cours attribués
AA-S05-CLAUDE-02	Claude	E45, E46, E50, E51
AA-S05-CLAUDE-03	Claude	E52, E54, E56, E58
AA-S05-CLAUDE-04	Claude	E59
AA-S04-CODEX-01	Codex	N17, N04, N29
AA-S04-CLAUDE-01	Claude	N18, N12, N27
AA-S06-CODEX-01	Codex	D69, D64, C85, C86
AA-S06-CODEX-02	Codex	C95, D63, D77
AA-S06-CLAUDE-01	Claude	D50, C77, C93, C94
AA-S06-CLAUDE-02	Claude	C96, D71, D73, D74

Ces lots sont des regroupements préparés, pas des conversations actives. Au lancement, sortir les quatre cours pilotes de leur lot sans les dupliquer. Commencer au plus deux missions simultanées par IA puis ajuster la capacité à la qualité mesurée ; scinder les tâches lourdes plutôt que raccourcir les vérifications.

N-05-Neurologie

Attributions 1–16 / 57. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
C70 — Tumeur maligne des méninges	Codex	P2	3	02
C72 — Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d’autres parties du système nerveux central	Claude	P2	8	01
G01 — Méningite au cours d’affections bactériennes classées ailleurs	Codex	P0	0	01
G02 — Méningite au cours d’autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs	Codex	P0	3	01
G03 — Méningite due à des causes autres et non précisées	Codex	P2	5	02
G05 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d’affections classées ailleurs	Codex	P0	4	01
G06 — Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens	Codex	P2	3	02
G07 — Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d’affections classées ailleurs	Codex	P2	0	03
G08 — Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes	Codex	P2	0	03
G09 — Séquelles d’affections inflammatoires du système nerveux central	Codex	P2	0	03
G21 — Syndrome parkinsonien secondaire	Codex	P2	7	03
G22 — Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	0	04
G23 — Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	Claude	P2	6	02
G24 — Dystonie	Codex	P2	8	04
G25 — Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	Codex	P2	12	04
G26 — Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d’affections classées ailleurs	Codex	P2	0	04

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

N-05-Neurologie — suite

Attributions 17–32 / 57. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
G32 — Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d’affections classées ailleurs	Codex	P2	2	05
G36 — Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées	Codex	P2	4	05
G37 — Autres affections démyélinisantes du système nerveux central	Codex	P2	8	05
G45 — Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	Claude	P1	28	01
G52 — Affections des autres nerfs crâniens	Codex	P2	7	05
G53 — Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	5	06
G55 — Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	5	06
G57 — Mononévrite du membre inférieur	Codex	P2	9	06
G58 — Autres mononévrites	Claude	P2	4	02
G59 — Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	2	06
G60 — Neuropathie héréditaire et idiopathique	Codex	P2	6	07
G63 — Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	8	02
G64 — Autres affections du système nerveux périphérique	Claude	P2	0	02
G71 — Affections musculaires primitives	Claude	P2	6	03
G72 — Autres myopathies	Claude	P2	9	03
G73 — Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	8	03

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

N-05-Neurologie — suite

Attributions 33–48 / 57. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
G80 — Infirmité motrice cérébrale	Claude	P2	7	03
G81 — Hémiparésie et hémiplégie	Claude	P2	3	04
G82 — Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie	Claude	P2	46	04
G83 — Autres syndromes paralytiques	Claude	P2	12	04
G90 — Affections du système nerveux autonome	Claude	P2	27	04
G91 — Hydrocéphalie	Claude	P2	9	05
G92 — Encéphalopathie toxique	Claude	P2	2	05
G93 — Autres affections du cerveau	Claude	P2	12	05
G94 — Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	9	05
G96 — Autres affections de système nerveux central	Claude	P2	4	06
G97 — Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs	Claude	P2	11	06
G98 — Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs	Claude	P2	0	06
G99 — Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	6	06
I61 — Hémorragie intracérébrale	Claude	P0	9	01
I62 — Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	Claude	P0	7	01
I63 — Infarctus cérébral	Codex	P0	9	01

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

N-05-Neurologie — suite

Attributions 49–57 / 57. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
I64 — Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	Codex	P0	0	02
I65 — Occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral	Claude	P2	6	07
I66 — Occlusion et sténose des artères cérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral	Codex	P2	7	07
I67 — Autres maladies cérébrovasculaires	Claude	P2	14	07
I68 — Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	4	07
R25 — Mouvements involontaires anormaux	Codex	P2	5	07
R26 — Anomalies de la démarche et de la motilité	Claude	P2	5	07
R27 — Autres troubles de la coordination	Claude	P2	2	07
R47 — Troubles du langage, non classés ailleurs	Codex	P2	3	08

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

E-06-Endocrinologie et métabolisme

Attributions 1–16 / 26. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
E00 — Syndrome d’insuffisance thyroïdienne congénitale	Codex	P2	4	01
E01 — Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode	Codex	P2	4	01
E02 — Hypothyroïdie par carence inapparente en iode	Codex	P2	0	02
E05 — Thyréotoxicose [hyperthyroïdie]	Codex	P1	8	01
E07 — Autres affections de la thyroïde	Codex	P2	4	02
E10 — Diabète sucré de type 1	Codex	P0	30	01
E11 — Diabète sucré de type 2	Claude	P0	30	01
E12 — Diabète sucré de malnutrition	Claude	P2	30	01
E14 — Diabète sucré, sans précision	Codex	P2	30	02
E25 — Anomalies génito-surrénaliennes	Codex	P2	7	02
E30 — Anomalies de la puberté, non classées ailleurs	Codex	P2	4	03
E32 — Maladies du thymus	Codex	P2	4	03
E34 — Autres troubles endocriniens	Claude	P2	11	01
E35 — Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	3	03
E40 — Kwashiorkor	Codex	P2	0	03
E41 — Marasme nutritionnel	Claude	P2	0	01

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

E-06-Endocrinologie et métabolisme — suite

Attributions 17–26 / 26. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
E42 — Kwashiorkor avec marasme	Codex	P2	0	04
E45 — Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique	Claude	P2	0	02
E46 — Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	Claude	P2	0	02
E50 — Avitaminose A	Claude	P2	10	02
E51 — Carence en thiamine [carence en vitamine B1]	Claude	P2	4	02
E52 — Carence en acide nicotinique [pellagre]	Claude	P2	0	03
E54 — Carence en acide ascorbique	Claude	P2	0	03
E56 — Autres avitaminoses	Claude	P2	4	03
E58 — Carence alimentaire en calcium	Claude	P2	0	03
E59 — Carence alimentaire en sélénium	Claude	P2	0	04

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

N-07-Néphrologie

Attributions 1–6 / 6. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
N04 — Syndrome néphrotique	Codex	P2	10	01
N12 — Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique	Claude	P2	0	01
N17 — Insuffisance rénale aiguë	Codex	P0	25	01
N18 — Maladie rénale chronique	Claude	P0	9	01
N27 — Petit rein de cause inconnue	Claude	P2	3	01
N29 — Autres affections du rein et de l’uretère au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	3	01

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

H-08-Hématologie

Attributions 1–15 / 15. Une seule IA par cours. Sous-codes : descendants à traiter dans le cours mère ; les SSP exacts sont disponibles dans le plan JSON. Les priorités P0/P1/P2 sont éditoriales et proposées.

Code — intitulé	IA	P	Sous	Lot
C77 — Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	Claude	P2	8	01
C85 — Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	Codex	P2	4	01
C86 — Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés	Codex	P2	7	01
C93 — Leucémie monocytaire	Claude	P2	15	01
C94 — Autres leucémies à cellules précisées	Claude	P2	19	01
C95 — Leucémie à cellules non précisées	Codex	P2	13	02
C96 — Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	Claude	P2	8	02
D50 — Anémie par carence en fer	Claude	P1	4	01
D63 — Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	Codex	P2	2	02
D64 — Autres anémies	Codex	P1	7	01
D69 — Purpura et autres affections hémorragiques	Codex	P0	20	01
D71 — Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles	Claude	P2	0	02
D73 — Maladies de la rate	Claude	P2	8	02
D74 — Méthémoglobinémie	Claude	P2	3	02
D77 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs	Codex	P2	0	02

Lot = suffixe du lot AA-[fragment]-[IA]-NN. Identifiants complets, SHA-256, chemins et gabarits de branches : plan.json et CSV audit dans le même dossier. Toutes les tâches sont préparées, non lancées.

La matrice des 20 rubriques

Ordre exact du Prompt de vérité. Chaque ligne reçoit « couvert » avec source et passage, « sans objet » motivé, ou « LACUNE » avec recherche tentée. Le rapport final ajoute l'onglet et l'identifiant HTML. Aucun statut n'est prérempli favorablement.

N°	Rubrique obligatoire
1	Question clinique et enjeu pour l'examen fédéral
2	Définition et périmètre CIM-10-GM (libellés OFS, inclusions, exclusions, notes BfArM)
3	Classifications et stades
4	Épidémiologie suisse puis européenne (incidence, prévalence, âge, sexe)
5	Normal → pathologique (anatomie, physiologie, mécanisme causal)
6	Étiologies et facteurs de risque
7	Anamnèse et symptômes (fréquences)
8	Examen clinique (signes, sensibilité/spécificité si disponibles)
9	Drapeaux rouges et urgences (seuil, délai, action)
10	Examens complémentaires (indication, valeur normale, seuil, interprétation, pièges)
11	Diagnostic différentiel (élément discriminant pour chaque diagnostic)
12	Prise en charge suisse (niveaux de soins, conduite, médicaments FI datés)
13	Complications et pronostic
14	Suivi, prévention, dépistage
15	Situations particulières (grossesse, enfant, âgé, insuffisance rénale/hépatique)
16	Spécificités suisses (déclaration OFSP, Suva/LAA, aptitude à la conduite, AI, remboursement LS/LiMA)
17	Critères formels du diagnostic (→ div.alert)
18	Paramètres clés chiffrés (→ div.key)
19	Sous-codes CIM-10-GM couverts (liste complète X00.0… et leur traitement)
20	Points d'examen fédéral (objectifs PROFILES/SSP, pièges classiques)

Dossier de preuves et cache fiable

Document de la leçon	Contenu minimal
recherche.md	Question clinique, plan des recherches et matrice exacte des 20 rubriques ; requêtes infructueuses et limites.
sources.json	Identifiant Sx, URL, titre/éditeur, version, consultation, section/page, niveau de lecture, population et limites ; produit suisse exact si médicament.
rapport.md / constats	Gravité, emplacement, source et passage, correction, contrôle du résultat, réserves et actions restantes.
missions/[identifiant].json	270 manifestes préparés, non lancés : base SHA40, mission, chemins, empreintes des sources et dépendances/assets. Les ressources externes inventoriées ne sont pas des passages déjà lus.
Contrôles et captures	Résultat réel de chaque contrôle, version finale testée ; captures ouverture et fenêtre explicative dans un dossier exclusif.

Réutiliser les preuves sans fabriquer une nouvelle lecture

Charger une fois le socle par empreinte et ouvrir seulement ses sections nécessaires ou changées. Le cache identifie le contenu par SHA-256, sa provenance, le lecteur, le passage consulté et son contexte. Réutiliser une preuve applicable ne signifie pas l’avoir relue. Ne pas recopier des documents entiers dans les prompts ou les dossiers.

Invalider la preuve si la source, sa version, la population, la décision ou une dépendance change. Relire le paragraphe et ses surfaces liées : fenêtres, tableaux, figures, quiz, résumés et autres onglets. Une correction de dose impose de vérifier ses adaptations et contre-indications, même si elles sont ailleurs.

Les adaptations avant toute écriture canonique

Ces protections sont proposées, pas déjà déployées. Le plan ne lance aucune correction, production ou publication. Une première livraison ne doit pas échouer dans une garde historique puis la contourner.

État actuel observé	Adaptation nécessaire au lancement
conversation_workspace.py : role audit exige l'autre IA et une mission auteur locale.	Pour Alpha sans croisement : snapshot détaché générique en lecture seule. Ne pas falsifier --actor ni inventer une mission auteur. Adapter l'outil séparément seulement si nécessaire.
Publication en l'état : provenance exacte et sources existantes identiques.	Une correction médicale ne relève pas de ce reçu. Implémenter et tester un reçu Alpha scoped à S08/S05/S04/S06 : instruction humaine, chemins, avant/après, preuves et statuts réels.
Scellements et preuves historiques conservés.	Ne pas les effacer ou promouvoir artificiellement un statut. Une nouvelle version possède ses propres empreintes ; aucune validation médicale manquante n'est inventée.
Baux locaux limités au .git commun.	Registre central CAS, générations/fencing et file durable d'intégration à implémenter ou allocateur/intégrateur unique effectif avant concurrence intermachines.

Tester l'acceptation d'une tâche valide et le refus des cas suivants : mauvais propriétaire/token, chemin hors périmètre, couverture concurrente, preuve d'ancienne version et modification d'un autre système. Appliquer l'autorité actuelle sans désactiver les gardes ni réécrire les anciens ordres.

Une responsabilité par tâche et par chemin



La clé d’attribution réunit campagne, tâche, cours racine, rôle, IA, conversation, environnement et génération. Deux conversations de Codex sont concurrentes autant que Codex et Claude. Chaque auteur possède sa branche, son worktree, son index Git et ses sorties de build/captures exclusifs.

Réserver à la tâche	Réserver à l’intégrateur unique
chapters/<CODE>/ ; glossary/<code>.py ; figures réellement propres ; dossier de preuves et livraison exclusif.	chapters.json, covers, catégories et alias, nosologie, catalogues de sources globaux, index/jauges, moteurs partagés, registres, workflows et sorties publiées.
Un cours entier et toutes ses surfaces ; sous-codes associés à leur leçon mère ; correction Alpha identifiée séparément, chemins inactifs avant gardes adaptées.	Une mutation de source partagée avec liste de consommateurs et effet attendu ; aucun écrasement d’un ancien catalogue entier.

L’exclusion couvre les préfixes de chemins et l’ensemble racine + covers + sous-codes + alias. Un nom de fichier distinct ne suffit pas si deux tâches traitent la même catégorie. Une image commune n’est pas un fichier propre ; demander sa mutation ou créer une copie propre attribuée.

Le rôle d’intégrateur reste symétrique

Une seule tâche d’intégration à la fois peut être confiée à Codex ou Claude et transférée explicitement. Elle ne confère aucune supériorité administrative et ne change pas la provenance des auteurs. La file durable conserve chaque demande et son reçu ; Actions concurrency seul ne remplace pas cette file.

Entre machines : CAS et générations

Un registre central versionné attribue les tâches par écriture conditionnelle sur son SHA/version précédent : lire, construire la transition, comparer et écrire, puis relire le reçu. Un conflit oblige à relire et recalculer. Une issue avec deux commentaires simultanés ou une mise à jour non conditionnelle de référence Git ne constitue pas une transaction.

Contrôle	Règle opérationnelle
Entrée de registre	Identifiant stable, code/racine/covers, chemins, propriétaire/conversation/environnement, base SHA, état, génération monotone, heartbeat/expiration, livraison et motif de transfert.
Expiration	État « à réconcilier », sans libération automatique. Conserver le travail ; transférer explicitement et augmenter la génération après arrêt confirmé ou exclusion effective de l’ancien auteur.
Fencing	Chaque soumission et intégration vérifie le token courant. Un ancien auteur hors ligne peut continuer à calculer, mais sa livraison obsolète est refusée.
Indisponibilité	Pas de nouvelle acquisition ni intégration sans registre. Lectures et travail déjà exclusif restent possibles, sans publication autonome.
Solution de repli	Si aucun CAS fiable n’est accessible aux deux machines, imposer un seul allocateur/intégrateur effectif ; aucune prise de tâche autonome concurrente.

Le fencing est réel uniquement si le chemin effectif vers main le vérifie. Un registre déclaratif contournable, un compte partagé ou --actor ne prouvent pas une identité distincte. Vérifier les protections GitHub accessibles ; ne pas promettre zéro collision ou zéro blocage.

Livrer, intégrer puis publier



Une demande de file contient un identifiant idempotent, la base, le SHA de livraison, les fichiers et empreintes, le token courant, les catégories/covers, les mutations partagées souhaitées et les réserves. L’intégrateur relit base/livraison/main, reconstruit sur une tête fraîche et remet un reçu du commit résultant.

Si main avance, le push normal doit échouer : reprendre le candidat sur la nouvelle tête, refaire les contrôles affectés et ne jamais forcer main. En cas de conflit, suspendre seulement la demande concernée, conserver branche et preuves, reprendre un petit diff ; aucune résolution aveugle ours/theirs ni fusion globale d’un ancien arbre.

Les preuves de publication restent distinctes

Contrôler les gardes adaptées, liens, glossaire, fenêtres, quatre onglets, figures et navigation ; exécuter les tests et builds pertinents sur la version finale. Vérifier publication.json, audit/sources.json, le SHA construit, les routes publiques et les statuts provisoires. Un build réussi ne vaut pas audit médical ou disponibilité publique.

Veto et historique

Codex et Claude disposent du même veto motivé. Le journal de gouvernance reste append-only ; une IA ne lève pas le veto de l’autre sans instruction humaine applicable et tracée. La levée se fait dans un commit distinct. Préserver tous les anciens plans, sceaux, rapports, sources et décisions ; ne pas relancer les veilles ou ordonnanceurs historiques.

Le pilote et la décision de lancement

Cours pilote — intitulé	IA
I63 — Infarctus cérébral	Codex
E11 — Diabète sucré de type 2	Claude
N17 — Insuffisance rénale aiguë	Codex
D50 — Anémie par carence en fer	Claude

Le pilote comporte quatre cours, deux par IA et un par système. Il vérifie les gardes adaptées, la complétude des preuves, la clarté du français, la charge réelle et l'absence de collision. Les quatre cours ne constituent pas un audit déjà effectué et ne lancent pas les autres lots.

Avant d'ouvrir les missions

Versionner le périmètre et l'attribution ; vérifier la tête de main et toutes les branches/PR paginées, livraisons, préparations et covers ; confirmer qu'aucun ancien cycle ou ordonnanceur n'écrit les mêmes chemins. Conserver les anciens plans comme sources documentaires, sans les réactiver.

Pour chaque mission : ouvrir missions/[assignment_id].json, confirmer IA/conversation, rôle, base SHA40, génération, branche/worktree, chemins propres et preuves. Ces manifestes ne sont pas des réservations actives. Lire le contrat compact par empreinte, puis les seules sections du socle nécessaires. Aucune copie globale d'un ancien arbre.

État : PREPARE_NON_LANCE. Aucun message à Claude, agent médical, rédaction, correction canonique, publication ou relance automatique n'est déclenché par ces PDF. Un lancement explicite et les adaptations vérifiées précèdent l'exécution.

Références : plan.json ; inventaire et CSV voisins ; prompt-verite-compact.yaml ; Prompt de vérité Betta (matrice exacte), PROMPT_MEDINA.md, PROMPT_TRANSITION.md, STYLE_REDACTION.md et instruction clarté/bases/calculs. La consigne actuelle s'applique aux quatre systèmes seulement ; les autres restent intacts.